

Peritonitis

1. Introducción y relevancia clínica

La **peritonitis** es la **inflamación del peritoneo**, membrana serosa que recubre la cavidad abdominal y las vísceras. Puede ser **localizada o generalizada**, y **séptica o estéril**, dependiendo de la etiología.

Constituye una **emergencia quirúrgica** que requiere diagnóstico rápido y manejo combinado: **reanimación, antibióticos y cirugía (cuando hay foco intraabdominal)**.

En Chile, la **peritonitis secundaria a perforación de víscera hueca** es una de las principales causas de abdomen agudo quirúrgico, seguida de apendicitis perforada y diverticulitis complicada.

Su mortalidad varía entre **5 y 40%**, dependiendo de la rapidez en el tratamiento, edad y comorbilidades (especialmente diabetes, cirrosis, EPOC y cáncer).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Clasificación según causa

Tipo	Etiología	Ejemplos
Primaria (espontánea)	Sin foco intraabdominal evidente; diseminación hematógena o linfática	Peritonitis bacteriana espontánea (PBE) en cirróticos
Secundaria	Perforación o infección intraabdominal	Apendicitis, úlcera péptica perforada, diverticulitis, trauma
Terciaria	Persistencia o recurrencia tras cirugía o antibióticos	Peritonitis postoperatoria, absceso residual, falla multiorgánica

2.2 Fisiopatología general

El peritoneo responde a la agresión con:

1. **Exudación de líquido rico en proteínas** → distensión abdominal.
2. **Reclutamiento inflamatorio** → aumento de permeabilidad capilar.
3. **Liberación de mediadores proinflamatorios (IL-1, TNF- α)** → **síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)**.
4. **Absorción bacteriana y toxinas** → **bacteriemia y sepsis**.
5. Si no se controla → **shock séptico y falla multiorgánica**.

El proceso puede ser **limitado** (absceso localizado) o **difuso** (peritonitis generalizada).

2.3 Microbiología

- **Primaria:** *E. coli*, *Klebsiella*, *Streptococcus spp.*
 - **Secundaria:** flora mixta polimicrobiana:
 - Aerobios: *E. coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*
 - Anaerobios: *Bacteroides fragilis*, *Peptostreptococcus*
 - En infecciones nosocomiales: *Pseudomonas*, *Enterococcus*, *Candida spp.*
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas cardinales

- **Dolor abdominal difuso**, progresivo, constante.
- **Fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos**.
- **Distensión abdominal** y sensación de plenitud.
- **Anorexia, malestar general, taquicardia**.

En fases avanzadas: **hipotensión, taquipnea, oliguria, confusión** → shock séptico.

3.2 Examen físico

- **Abdomen rígido (“tabla”)**, con **defensa muscular y rebote positivo (signo de Blumberg)**.
- **Ruidos intestinales abolidos.**
- **Signo de Murphy negativo** (diferencia con colecistitis).
- En casos localizados: **dolor focal** (p. ej. fosa iliaca derecha en apendicitis perforada).

En ancianos, diabéticos o inmunocomprometidos, el cuadro puede ser atenuado o insidioso.

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferenciación clave
Apendicitis aguda	Dolor localizado inicialmente; no difuso al inicio
Pancreatitis aguda	Amilasa/lipasa >3x; TAC muestra inflamación pancreática
Colecistitis aguda	Dolor en HCD, Murphy positivo
Isquemia mesentérica	Dolor desproporcionado, lactato elevado
Perforación de víscera hueca	Aire libre subdiafragmático
Obstrucción intestinal	Vómitos y distensión predominantes, sin rigidez inicial

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Laboratorio

- **Hemograma:** leucocitosis (>15.000) con desviación izquierda.
 - **PCR y procalcitonina:** elevadas, correlacionan con sepsis.
 - **Electrolitos:** hiponatremia, hipocalemia.
 - **Urea/creatinina:** indican deshidratación o falla renal.
 - **Lactato sérico elevado:** signo de hipoperfusión y mal pronóstico.
 - **Hemocultivos:** positivos en 30–40% (especialmente en peritonitis primaria o terciaria).
-

4.2 Imágenes

A. Radiografía simple de abdomen / tórax

- Aire libre subdiafragmático (perforación).
- Niveles hidroaéreos (íleo paralítico secundario).
- Distensión intestinal generalizada.

B. TAC abdominopélvico con contraste (Gold standard)

- Identifica:
 - Líquido libre (densidad intermedia).
 - Gas extraluminal.
 - Engrosamiento peritoneal.
 - Foco causal (apéndice, divertículo, úlcera).
 - Abscesos o colecciones.
- Es el **examen diagnóstico y de planificación quirúrgica principal**.

C. Ecografía

- Útil para detectar líquido libre, abscesos o perforación biliar.

D. Paracentesis diagnóstica

- Indispensable en cirróticos o pacientes con ascitis:
 - PMN $\geq 250/\text{mm}^3$ confirma **peritonitis bacteriana espontánea (PBE)**.
 - Cultivo positivo orienta a germen causal.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / WSES / IDSA 2021)

5.1 Objetivos

1. Controlar la infección intraabdominal.
 2. Eliminar el foco séptico (quirúrgico si corresponde).
 3. Corregir las alteraciones hemodinámicas.
 4. Prevenir o tratar el shock séptico.
-

5.2 Manejo inicial

- **Ayuno absoluto.**
 - **Fluidoterapia vigorosa:** Ringer lactato o suero fisiológico.
 - **Sonda nasogástrica** para descompresión.
 - **Sonda vesical** para control de diuresis ($>0,5 \text{ mL/kg/h}$).
 - **Monitoreo hemodinámico y oxigenación.**
-

5.3 Antibióticos empíricos (inicio inmediato)

- **Peritonitis comunitaria (no hospitalaria):**
 - *Ceftriaxona + Metronidazol*, o
 - *Ampicilina/sulbactam*, o
 - *Cefotaxima + Metronidazol*.
- **Peritonitis nosocomial o severa:**
 - *Piperacilina/Tazobactam* o *Carbapenémico (Meropenem)*.
 - Añadir *Fluconazol* si sospecha de *Candida* (p. ej. postoperatorio prolongado).

Duración: **5–7 días**, o hasta resolución clínica.

5.4 Tratamiento específico según tipo

A. Peritonitis primaria (espontánea)

- Más frecuente en cirróticos con ascitis.
- Diagnóstico: PMN $\geq 250/\text{mm}^3$ en líquido ascítico.
- Tratamiento:
 - **Ceftriaxona 2 g/día IV** o **Cefotaxima 2 g/8 h IV** por 5 días.
 - **Albumina IV** (1,5 g/kg al diagnóstico y 1 g/kg a las 48 h) reduce insuficiencia renal.
 - Profilaxis secundaria: *Norfloxacino 400 mg/día VO*.

B. Peritonitis secundaria (quirúrgica)

- Origen: perforación, absceso o trauma.
- Manejo:
 1. **Cirugía urgente:** laparotomía o laparoscopia para lavado y control del foco.

2. **Cierre de perforación o resección** según causa.

3. **Drenaje de colecciones.**

Ejemplos: cierre de úlcera perforada, apendicectomía, sigmoidectomía en diverticulitis perforada, reparación de víscera lesionada.

C. Peritonitis terciaria

- Infección persistente o recurrente tras cirugía y antibióticos.
 - Germen multirresistentes o fúngicos.
 - Requiere manejo en UCI con antibióticos de amplio espectro, drenaje y control de foco.
-

5.5 Cuidados postoperatorios

- Monitoreo hemodinámico y diuresis.
 - Nutrición parenteral o enteral precoz según estabilidad.
 - Control de drenajes y temperatura.
 - Ajuste antibiótico según cultivo.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Consecuencia
Sepsis y shock séptico	Falla multiorgánica	Alta mortalidad
Abscesos intraabdominales	Persistencia de infección localizada	Requiere drenaje

Íleo paralítico prolongado

Inflamación peritoneal difusa

Retardo en realimentación

Insuficiencia renal aguda

Hipoperfusión o sepsis

Diálisis temporal

Fístulas enterocutáneas

Lesión intestinal o dehiscencia

Pérdida de líquidos/proteínas

Pronóstico:

- Mortalidad global: 10–20%.
- Aumenta con edad >70 años, retraso quirúrgico >24 h y sepsis persistente.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Dolor abdominal difuso + abdomen en tabla + leucocitosis = peritonitis hasta demostrar lo contrario.**
 2. **TAC con contraste es el examen más útil para confirmar el diagnóstico y buscar el foco.**
 3. **El tratamiento antibiótico nunca sustituye la cirugía** cuando hay perforación o absceso.
 4. **Peritonitis primaria (cirrótico)** se maneja solo con **antibióticos y albúmina**, sin cirugía.
 5. **La mortalidad se relaciona directamente con el retraso quirúrgico.**
 6. En peritonitis terciaria, **considerar Candida y gérmenes multirresistentes.**
-



Errores comunes

- Omitir **TAC abdominal** ante diagnóstico incierto.
 - No iniciar antibióticos **antes del pabellón**.
 - Intentar manejo médico exclusivo en **perforación libre**.
 - No medir **lactato** o no monitorizar diuresis.
 - Suspender antibióticos precozmente sin control clínico.
 - No indicar **profilaxis antibiótica ni albumina** en cirróticos con PBE.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **peritonitis** es una inflamación del peritoneo que puede ser **primaria (espontánea)** o **secundaria (perforación/infección)**.
2. Causa un **abdomen agudo grave** con **dolor difuso, rigidez y signos sépticos**.
3. **TAC con contraste** es el método diagnóstico más útil.
4. Manejo inicial: **reanimación, antibióticos y control quirúrgico del foco**.
5. **Peritonitis primaria (cirrótico)** se trata con **ceftriaxona + albúmina**.
6. **Peritonitis secundaria** requiere **cirugía urgente**.
7. El **retraso en la cirugía >24 h** multiplica la mortalidad.